

מדיניות המרכז הרפואי הדסה נוהל שימוש וטיפול בחלב אם בבית החולים מספר: 02-02-05-07			המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה מסודר שד ארגון נשות הדסה אנאליים הדסה חלב
הספר: 02 - שרותי רפואה		התחום: 02 – מחלקות אשפוז	
הנושא: 05 - ילדים ויילודים		הנוהל: 07 - שימוש וטיפול בחלב אם בבית החולים	
מהדורה: שנייה		עדכון ופרסום: ספטמבר 2024	עמוד 1 מתוך 12
הנוהל נכתב ע"י: פרופ' סמדר אבן-טוב פרידמן מנהלת האגף לנאונטולוגיה, מיכל נאה דיאטנית מחלקת דיאטה ותזונה ע"כ, טליה לב מ.מ. אחות ראשית פגיה ויועצת הנקה, שחרית הרמן מרכזת נושא הנקה ה"צ, נדיה קוריאקין מרכזת נושא הנקה ע"כ.			
הנוהל אושר ע"י: פרופ' יניב שרר מנהל בית החולים ע"כ, דר' תמר אלרם מנהלת בית החולים ה"צ, דר' רלי אלון סמנכ"לית סיעוד ומקצועות הבריאות, פרופ' סמדר אבן-טוב פרידמן מנהלת האגף לנאונטולוגיה, ד"ר יונתן אוסטר מנהל יחידת מניעת זיהומים, אילנה גרוס מרכזת תחום מניעת זיהומים, אילן לוי מנהל אגף אחזקה ובינוי.			
גורם מתאם בבית החולים: ציפי עזריה שיפמן מנהלת תחום נהלים וסטנדרטים מקצועיים, המערך לאיכות ובטיחות.			
תחומי האקרדיטציה: 1 IPSG, 9 PCI (מהדורה 7 JCI)			
הנוהל מיועד לנשים ולגברים כאחד			

1. מבוא

- 1.1. הנקה הינה המזון המועדף (gold standard) להזנת תינוקות ומוכרת ע"י ארגוני בריאות ורפואה בארץ ובעולם כסוגיה בבריאות הציבור ולא רק כבחירה של סגנון חיים.
- 1.2. חלב אם מורכב משילוב ייחודי של שומנים, סוכרים, מינרלים, חלבונים, ויטמינים ואנזימים, מותאם לגדילה והתפתחות גופנית ושכלית אצל התינוק והפעוט (AAP-Breastfeeding and Use Human Milk 2007).
- 1.3. חלב אם הוא המזון המיטבי לילוד, והוכח כי הוא מגן מפני זיהומים ומשפר מדדי התפתחות. הנקה ומתן חלב אם לילוד תורמות לבריאות האם והילוד.
- 1.4. הנקה ישירה מהשד היא הדרך העדיפה להזנת תינוקות.
- 1.5. סדר העדיפות שקבע ארגון הבריאות העולמי (WHO) להזנת תינוקות הוא:

1.5.1. הנקה.

1.5.2. חלב שאוב מהאם הביולוגית.

1.5.3. חלב אם מפוסטר מבנק חלב מורשה.

1.5.4. תרכובות מזון לתינוקות (תמ"ל) כחלופה אחרונה.
- 1.6. על הצוות הסיעודי והרפואי לעודד ולתמוך, במידת האפשר, בהנקה ישירה, או מתן חלב אם שאוב.
- 1.7. עידוד, הדרכה ותמיכה אקטיביים ע"י צוותים מקצועיים במהלך ההיריון ולאחר הלידה, נמצאו כגורם משמעותי בהארכת משך ההנקה הבלעדית והמשולבת.

2. מטרה

- 2.1. קביעת עקרונות אחידים לאחסון, שימוש, טיפול וזיהוי של חלב אם שאוב (expressed milk breast) בבתי החולים של הדסה לצורך שמירת איכותו ובטיחות השימוש בו.
- 2.2. הגדרת גבולות האחריות של הצוות המטפל באחסון, הכנה ושימוש בחלב אם.

3. חלות

- 3.1. כלל אנשי הצוות הרפואיים, הסיעודיים ומקצועות הבריאות, העובדים במחלקות בהן מתבצע האחסון והשימוש בחלב אם.

4. סמכות ואחריות

- 4.1. באחריות מנהלת אגף נאונטולוגיה, מנהלי המחלקות ומנהלת חטיבה מיילדותית לדאוג לתשתיות נאותות לשאיבת ואחסון חלב אם.
- 4.2. באחריות הצוות המטפל להדריך את ההורים לשאיבה, אחסון, הכנה ושימוש בחלב אם.

5. הגדרות

- 5.1. **"שאיבת חלב אם"**: פעולה של הוצאה מכנית של חלב מהשד המתבצעת בהיעדר הנקה ישירה, או בנוסף אליה במטרה לבסס ולשמר יצירת חלב. השאיבה מתבצעת על ידי אם הילוד בשיטה ידנית או באמצעות משאבה חשמלית. החלב הוא תוצר השאיבה.
- 5.2. **"כלים ייעודיים לאחסון ומתן חלב אם"**: כלי נקי ומעוקר הניתן לסגירה והניתן להקפאה, להפשרה ולחימום יבש עד 40 מעלות (העומד בתקן ישראלי 5817) כלי למזון לתינוקות עד גיל 3 שנים, או שקית ייעודית לאחסון חלב (בתקן 5113 או בתקן 14372) או מזרק לשימוש פומי.
- 5.3. **"מדבקת מטופל"**: מדבקת אשפוז בה מופיעים פרטי הילוד או היולדת: מספר זהות זמני או קבוע, שם (במקרה של יילוד - בן/בת של), שם משפחה, מספר זהות האם, שנת לידה, מחלקת אשפוז.
- 5.4. **"תרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל)"**: הינו מוצר מזון הנועד לשמש כמקור תזונה לתינוקות ופעוטות, במקום חלב אם באופן מלא או חלקי, כאשר חלב אם אינו זמין.
- 5.5. **"צוות רב מקצועי"**: כולל נציגות של המקצועות הבאים: סיעוד, יעוץ הנקה, רפואה, תזונה ומניעת זיהומים.

6. שיטה

6.1. צוות רב מקצועי (נספח 1):

- 6.1.1. הנהלת המוסד הרפואי תקים צוות רב-מקצועי לארגון השימוש הבטוח בחלב אם שאוב (expressed breast milk) במוסד.
- 6.1.2. הצוות הרב מקצועי אחראי על:
 - 6.1.2.1. הטמעת תהליכי הטיפול בחלב אם החל משאיבתו ועד לשלב הזנת התינוק, באופן המשמר את התכונות הייחודיות של החלב ואיכותו התזונתית תוך שמירת איכות ובטיחות השימוש בו במוסד (נספח 1).
 - 6.1.2.2. בניית תכנית הדרכה, הכשרה והטמעה לכל עובדי המוסד העוסקים או הבאים במגע עם חלב אם.
 - 6.1.2.3. בנייה והטמעת תכנית של בקרת איכות.
- 6.2. **עקרונות:**
 - 6.2.1. טיפול בחלב אם יעשה במטבח חלב או בשטח ייעודי, תוך כדי הקפדה על היגיינה אישית מתאימה ורחיצת ידיים.
 - 6.2.2. ניקוי משטחים לפני הטיפול בחלב, עבור כל תינוק, יעשה לפי באמצעות מגבוני אנטיגון.
 - 6.2.3. טיפול ואחסון של חלב אם יעשו בכלים ייעודיים לחלב אם.
 - 6.2.4. יש להגן על חלב אם שאוב מנזקי אור וחום על מנת לשמר את ערכו התזונתי.
- 6.3. **שאיבת חלב:**



- 6.3.1. שאיבת החלב יכולה להיעשות באזור שאיבה משותף או בסמוך למיטת היולדת או התינוק.
- 6.3.2. יש לקבוע אזור ייעודי לשאיבת חלב אם הכולל: משטח עבודה, אחסון ציוד השאיבה, מכלי אחסון החלב וכיור.
- 6.3.3. שאיבת חלב ליד עריסת התינוק מסייעת להפקת החלב ומותרת בתנאי שקיימים תנאים לרחיצת ידניים, משטח סמוך שעבר ניקוי וחיטוי לפני השאיבה והציוד הנדרש לשאיבה.
- 6.3.4. משאבת החלב המשותפת תהיה בעלת אישור אמ"ר ומדגם המוגדר כמותאם לשימוש על ידי מספר משתמשות במקביל (multiple users pump).
- 6.3.5. שימוש במשאבה ותחזוקתה יעשה בהתאם להוראות היצרן ובהתאם להמלצות היחידה למניעת זיהומים. אין לבצע שינויים במערכת השאיבה ואביזריה.
- 6.3.6. האחריות לבדיקה תקופתית של המשאבות, הינה של מתאמת ההנקה במוסדית מול חברת המשאבות, ובהתאם להוראות היצרן.
- 6.3.7. חלקי הסט לשאיבת חלב המיועדים לשימוש אישי יוחלפו, ינוקו ויעברו עיקור על פי הוראות היצרן בין שאיבות ע"י אותה משתמשת ובמעבר בין משתמשת אחת לאחרת.
- 6.3.8. כאשר נשאב חלב בגוון חלודה/דמי, ניתן להשתמש בו. זהו חלב תקין.
- 6.3.9. יש להנחות להמשך הנקה/שאיבה כרגיל. התופעה חולפת עם הזמן.
- 6.4. זיהוי חלב אם לאחר שאיבתו:**
- 6.4.1. יש לבצע תהליך לצורך זיהוי חד-חד ערכי של חלב האם מיד לאחר השאיבה הכולל לפחות שני פרטים מזהים: שם מלא של האם, מספר תעודת זהות של האם.
- 6.4.2. במקרה שבו האם מביאה חלב ששאבה בביתה, לא ניתן יהיה לבצע את הזיהוי חד-חד ערכי של החלב מיד לאחר השאיבה, אלא עם הבאת החלב למחלקה וטרם מתן החלב.
- 6.4.3. חלב שאוב, בסיום תהליך השאיבה יועבר לכלי לאחסון חלב ייעודי, כל מנה תסומן ע"י האם במדבקת ילוד, עליה ירשמו תאריך ושעת שאיבה.
- 6.4.4. הגישה למקררי החלב תוגבל, ותתאפשר לאנשי צוות המחלקה בלבד. מקררי החלב יסומנו בהתאם.
- 6.4.5. כל טיפול בחלב אם, כולל הכנסתו והוצאתו מהמקרר יעשה תוך בקרת זיהוי.
- 6.4.6. באחריות האחיות הראשיות במחלקות להגדיר את המורשים לבצע זיהוי חלב אם, ולהדריכם.
- 6.5. השימוש בחלב מבנק חלב אם:**
- 6.6. חלב מבנק חלב יישמש לתזונת תינוק בעת מחסור או העדר חלב האם הביולוגית בהתאם להתוויה רפואית ואישור ההורים.
- 6.7. הבנק יספק 2 סוגי חלב:**
- 6.7.1. P "חלב פגים": חלב שנשאב על ידי אימהות לפגים ב-6 השבועות הראשונים לאחר הלידה.
- 6.7.2. M "חלב בשל": חלב שאיננו חלב פגים.
- 6.7.3. התיעדוד ביחידה יעשה על פי החלטת הצוות הרפואי.
- 6.7.4. הורי תינוקות העומדים בקריטריונים שיקבעו ע"י משרד הבריאות, יוחתמו על הסכמה/אי הסכמה למתן חלב מבנק חלב לאחר שיחת הסבר עם יועצת הנקה מהפגייה ורופא.
- 6.7.5. חלב מהבנק יגיע קפוא ומפוסטר וישמר במצב זה עד להפשרתו לקראת ההזנה.
- 6.7.6. לפני המתן יש לבדוק את תאריך התפוגה וכי פקק הביטחון סגור.



6.7.7. חלב מהבנק יכול להישאר עד יממה במקרר לאחר הפשרתו המלאה.

6.7.8. ניתן לחלק את המנה בין תינוקות שונים או להאכיל במנה מסוימת לאורך היממה.

6.7.9. יש לתעד את נתוני האצווה בתיק הרפואי.

6.8. חלוקה למנות:

6.8.1. נפח המנות יקבע על פי הוראה רפואית.

6.8.2. החלוקה למנות תתבצע תוך שימוש באביזרים המיועדים לשימוש פומי על גבי משטח עבודה ייעודי ונקי במטבח חלב או ביחידה באזור ייעודי, למטופל אחד בכל פעם.

6.8.3. את משטח העבודה יש לנקות במגבון אנטיגון או מטלית כלור, כל פעם, לפני תחילת העבודה.

6.8.4. החלוקה למנות תכלול זיהוי חד חד ערכי אל מול מדבקת זיהוי מיכל האחסון והרשומה הרפואית.

6.8.5. יש לבצע בקרה כפולה על ידי שני אנשי צוות או איש צוות והורה התינוק מול ידון התינוק לפני מתן המנה.

6.8.6. מכלי האחסון יזוהו באופן מיידי וברור לאחר החלוקה למנות ויכללו סימון תאריך ושעת ההכנה על גבי מדבקת אשפוז של הילוד/ יולדת.

6.8.7. שיתוף ההורים בשלבי התהליך בהכנת החלב עשוי להפחית טעויות זיהוי והעלאת מעורבותם בטיפול בילדם.

6.8.7.1. שיתוף הורים יעשה לאחר הדרכה לעקרונות בטיחות וזיהוי.

6.9. אחסון חלב האם: (נספח 3)

6.9.1. חלב שאוב, בסיום תהליך השאיבה יועבר לכלי לאחסון חלב ייעודי, יסומן ע"י האם במדבקת אשפוז של הילוד/ היולדת וסימון תאריך ושעת שאיבה.

6.9.2. חלב אם ישמר במקרר ייעודי בטמפרטורה של 0-4 מעלות צלזיוס עם בקרת טמפרטורה מרכזית.

6.9.3. חלב אם ישמר במקרר או במקפיא באזורים ייעודיים ומסומנים, או במקרר תמ"ל ומזון ייעודי, בתנאי שקיימת הפרדה ביניהם ובין חלב האם.

6.9.4. יש להקפיד על הפרדה ברורה בין חלב שאוב של מטופלים שונים בסלסלה ייעודית הנושאת שלט: "חלב אם" + שם המטופל.

6.9.5. יש להשוות את המדבקה על הכלי הייעודי לסימון במקרר האחסון/ סלסלת האחסון האישית.

6.9.6. בכל שאיבה, כמות החלב תאוחסן בכלי נפרד.

6.9.7. ניתן לצרף חלב שנשאב בזמנים שונים, רק לאחר הבאתם לאותה טמפרטורה במקרר.

6.9.8. לאחר שעה במקרר תהיה השוואת טמפרטורה.

6.9.9. תאריך ושעת השאיבה המסומנת תהיה המוקדמת ביותר מבין השאיבות שצורפו. מומלץ לעשות הערכה של כמות החלב אותו התינוק צריך ולהקפיא את היתרה בסמוך ככל הניתן לשאיבה.

6.9.10. במידה שהשאיבה מתבצעת מחוץ לבית החולים, יש לאחסן את החלב בקירור ולהביאו למחלקה באמצעות צידנית וקררר.

6.9.11. עם ההגעה לבית החולים יש להעבירו למקרר ייעודי בהתאם להנחיות לעיל.

6.9.12. החלב המסומן יוכנס למקרר האישי על ידי איש צוות בלבד לאחר בדיקת פרטי הזיהוי ומועד השאיבה, אשר מסומנים על גבי מדבקת הילוד.

6.9.13. בכל מעבר של תינוק בין מחלקות, יש להעביר את החלב השאוב עם התינוק.

6.10. משך אחסון החלב: (נספח 3)



- 6.10.1. ישנה עדיפות לשימוש בחלב אם בעודו טרי. בתהליך הקירור יורד ערכם של גורמים אנטי דלקתיים.
- 6.10.2. חלב טרי יינתן ישירות לתינוק ללא חימום. חלב ישמר, באופן מיטבי, בטמפרטורת החדר 22-25 במשך שעה. אם החלב מיועד לשימוש בתוך שעה, יש להשאירו בטמפ' החדר על מנת למנוע קירור וחימום של החלב הטרי, תוך תאום בין ההורה עם הצוות המטפל.
- 6.10.3. הכמות המיועדת לשימוש תאוחסן במקום ייעודי שיקבע בהתאם לנהלי מחלקה. חלב שנשאב ולא מיועד לשימוש בתוך שעה, יאוחסן במקרר בסמוך לזמן השאיבה, בהקדם ולא יאוחר מארבע שעות, וישמר בקירור בטמפרטורה של 0-4 מעלות צלזיוס עד 72 שעות מרגע השאיבה.
- 6.10.4. חלב שפג תוקפו - ייזרק.
- 6.10.5. במקרים מיוחדים (לדוגמא חגים ארוכים) יוארך תוקף השימוש בחלב באישור רופא בכיר.
- 6.10.6. תוקף הארכה מקסימלית: עד חמישה ימים. חלב שלא חומם, חלב טרי או חלב שהוצא מקירור, ישמר בטמפרטורת חדר עד ארבע שעות לאחר הוצאתו. מרגע חימום החלב, יש לתת את החלב בתוך שעה.
- 6.10.7. חלב אם מקורר המאוחסן בציידנית עם קרחון, מתאים לשימוש בתוך 8 שעות, או שניתן להעבירו להמשך אחסון בקירור.
- 6.10.8. חלב שלא יצרך בתוך 72 שעות, ניתן להקפיא בבית (או בפגיה, במצב שהתינוק מאושפז) מוקדם ככל האפשר ותוך 24 שעות מרגע השאיבה, במידה שקורר מיד לאחר שאיבתו.
- 6.10.9. חלב בהקפאה $> 18^\circ$ – (טמפרטורה של מינוס 18 מעלות ונמוך יותר) תוקף השימוש עד 3 חודשיים, אחסון מרבי 12 חודשים. החלב יסומן לפני ההקפאה בתאריך ושעת שאיבה. ההקפאה תעשה בכמות של עד 100 מ"ל על מנת להקל על ההפשרה ולהימנע מזריקת חלב.
- 6.11. הקפאת חלב אם והפשרתו: (נספח 3)
- 6.11.1. הקפאת חלב אם והפשרתו תנוהל כמפורט בנספח 3.
- 6.11.2. אין להחזיר למקפיא חלב שהופשר. ניתן להפשיר חלב אם על ידי הוצאתו מהמקפיא למקרר ייעודי מבעוד מועד או בשימוש במכשיר חימום יבש ייעודי תוך הגנה בפני אור.
- 6.11.3. אין להפשיר את החלב באמצעות השרייה בנוזלים חמים/חימום במיקרוגל/הרתחה.
- 6.11.4. החלב יוגדר כחלב מופשר- כאשר אין בו גושי קרח.
- 6.11.5. יש לציין שעת הוצאה מההקפאה ושעת הפשרה על מדבקת הילוד או על גבי מדבקה ייעודית.
- 6.11.6. חלב אם שהופשר במקרר ולא חומם, טוב לשימוש במשך 24 שעות. לאחר 24 שעות החלב הנותר ייזרק. כאשר אם היונק משתמש בחלב קפוא – על יועצת הנקה להעריך את תפוקת החלב ולהדריך להגברת תפוקת החלב במידת הצורך.
- 6.12. חימום חלב אם:
- 6.12.1. במחמם יבש, ייעודי שהוגדר לכך באישור אמ"ר ובלבד שטמפרטורת החלב לא תעלה מעל 40 מעלות צלזיוס.
- 6.12.2. בבקבוקים או במזרקים יעודים העומדים בתקן והמסומנים במדבקת זיהוי.
- 6.13. הכנת חלב אם לשימוש:
- 6.13.1. הכנת הכלכלה תעשה בהתאם להוראה רפואית. חלוקת החלב למנות, לשימוש עבור הילוד, תעשה על ידי צוות מטפל בהתאם לצורך, או על ידי
- 6.13.2. ההורה לאחר שקיבל הדרכה מפורטת וביצע פעם אחת לפחות עם אחות וקיבל הרשאה לכך.



- 6.13.3. ראה [נספח 4](#) הנחיות לשאיבת חלב ליולדות/אמהות לפגים.
- 6.13.4. שימוש בחלב אם שנמצא בקירור יעשה בשיטת FIFO- FIRST IN FIRST OUT.
- 6.13.5. קולוסטרום יינתן על פי הסדר הכרונולוגי של השאיבה עד לסיום מנות הקולוסטרום.
- 6.13.6. חלב אם שמאוחסן במקרר עובר תהליך של הפרדה לשתי שכבות: שכבה שומנית ושכבה מימית.
- 6.13.7. לפני השימוש יש לערבב קלות בתנועה סיבובית את הכלי הייעודי בו נמצא החלב. לפני מתן החלב השאוב יש לבדוק את טמפרטורת חלב על גב כף היד של הורה, אם נמצא, או של האחות, ולבצע רחצת ידיים מלאה לאחר מכן. יש להימנע מחימום יתר הפוגע במרכיבים ייחודיים בחלב.
- 6.13.8. בכל שימוש בחלב תעשה בקרה כפולה על ידי שני אנשי צוות או איש צוות+ הורה. תיבדק:
- 6.13.8.1. ידון המטופל.
- 6.13.8.2. תוקף תאריך ושעה.
- 6.13.9. חלב המיועד למתן מתמשך יש להכניס למקרר מיד לאחר סיום השאיבה, אלא אם מיועד לשימוש מיידי. לאחר הקירור יש להביאו לטמפרטורת חדר בלבד. כמות החלב שתוכן בכל פעם תהיה בכמות הניתנת לתינוק במשך 4 שעות.
- 6.14. **חלוקת חלב אם לילודים:**
- 6.14.1. מתן החלב יהיה על פי התיעדון הבא:
- 6.14.1.1. חלב אם טרי.
- 6.14.1.2. חלב אם מקורר.
- 6.14.1.3. חלב אם קפוא.
- 6.14.1.4. חלב אם בתוספת חלב מבנק חלב אם.
- 6.14.1.5. חלב אם בשילוב עם תמ"ל.
- 6.14.2. בכל חלוקת חלב אם לילוד יבוצע זיהוי חד חד ערכי נוסף אל מול העריסה והידון לאחר חימום החלב.
- 6.14.3. חשוב לציין:
- 6.14.3.1. קיימת עדיפות לשימוש בחלב אם טרי או מקורר על פני חלב קפוא.
- 6.14.3.2. אין להשתמש בחלב מתורמת שלא מבנק החלב הלאומי.
- 6.15. **ניקיון:**
- 6.15.1. בקבוקים ופטמות להאכלה בבית חולים הינם חד פעמיים. יש לזרוק אותם לאחר השימוש.
- 6.15.2. אין להרטיב את הצינור השאיבה המתחבר למכונה, הרטבתו יכולה לפגוע במנוע המכונה.
- 6.15.3. בתום שימוש במשאבה הנמצאת בחדר היולדת, המשאבה תעבור ניקוי על ידי כוח עזר באמצעות מטלית חיתוי ייעודית כגון אנטיגון או במטלית סחוסה טבולה בתמיסת כלור בריכוז 1000 ppm או בהתאם להנחיות היצרן. לאחר הניקוי היא תכוסה בשקית ניילון ועליה מדבקה עם תאריך הניקוי.
- 6.15.4. במידה שהשאיבה נעשתה באזור שאיבה ייעודי, האם תונחה לנקות את פני המשאבה (חלקה החיצוני) עם מגבוני אנטיגון לאחר השימוש. אחת ליממה המשאבות ינוקו על ידי כוח עזר/ סטודנט במגבון אנטיגון, או במטלית ספוגה בכלור בריכוז 1000 ppm כאשר היא סחוסה היטב.
- 6.15.5. הניקוי של חלקי ערכת השאיבה יעשה באמצעות מברשת אישית עם מים וסבון לאחר כל שימוש, והקפדה על ייבוש על מגבת נייר נקיה נפרדת מכלים אחרים.



6.15.6. חיטוי חלקי ערכת שאיבה רב פעמית יעשה בבית החולים פעם ביממה, לאחר ניקוי כמוסבר בסעיף הקודם, באמצעות מדיח ייעודי (לפי ההוראות ב**נספח 2**) או בשקיות ייעודיות לסטריליזציה במיקרוגל או על ידי חיטוי קר באמצעות השרייה בתמיסת כלור בריכוז 1000 ppm למשך 10 דקות.

6.15.7. לאחר מכן יש לשטוף את ערכת בשאיבה היטב במים זורמים על מנת להיפטר מעודפי הכלור ולייבש.

6.15.8. אין לעקר ערכות שאיבה המיועדות לשימוש יומי בלבד. ניתן להדריך הורים לעקר את חלקי ערכת השאיבה ע"י שפיכת מים רותחים על כל חלקי הערכה, בתוך כלי ייעודי, עמיד לחום, והשרייתו במשך 5 דקות.

6.15.9. יש להדגיש בהדרכה אזהרת בטיחות ואין לאפשר ביצוע העיקור בחדר היולדת או בסמוך לעריסת תינוק.

6.16. מתן הדרכה להורים:

6.16.1. באחריות הצוות המטפל להדריך את ההורים לשאיבה, אחסון, הכנה ושימוש בחלב אם. ההדרכה תתועד באופן מפורט במקום ייעודי לכך.

6.16.2. מועד ההדרכה: בקבלת יונק למחלקה ולא יאוחר מיממה ראשונה לאשפוז. במידה והאם לא מאושפזת עם התינוק, יש להדריך על שאיבה, אחסון ושינוע חלב אם למחלקה תוך שמירה על היגיינת ידיים. כמפורט ב**נספח 4**.

6.17. דווח ותיעוד:

6.17.1. אחות תתעד את שעת האכלה, סוג הכלכלה, כמות שניתנה, כמות שנאכלה, PO וכמות שנתנה PG PZ / בגיליון המטופל.

7. הכשרה והטמעה

- 7.1. הנוהל יופץ לעובדים באופן ישיר למייל האישי שלהם בהדסה ועל-ידי המנהלים הישירים.
- 7.2. העובדים ידרשו לחתום על קריאת הנוהל במערכת Teach.
- 7.3. הדרכה בנוגע לנוהל זה תינתן בעת קבלת עובד חדש למחלקה.
- 7.4. באחריותם של מנהלי המחלקות והאחיות הראשיות להטמיע נוהל זה בקרב העובדים שלהם.

8. סימוכין

- 8.1. משרד הבריאות: חוזר חטיבת רפואה, בנושא: [הנחיות לשימוש וטיפול בחלב אם בבית החולים](#), מספר: 1/2020
- 8.2. משרד הבריאות: חוזר שירותי בריאות הציבור, בנושא: [בנק חלב אם](#), מספר: 4/2016
- 8.3. משרד הבריאות: חוזר חטיבת רפואה, בנושא: [הכנת תרכובות מזון לתינוקות ותרכובות מזון ייעודי](#) [במוסדות רפואיים](#), מספר: 18/2014

9. נספחים

- 9.1. נספח 1: [צוות רב-מקצועי לארגון השימוש הבטוח בחלב אם שאוב](#).
- 9.2. נספח 2: [הטיפול בכלים ובאביזרים לשאיבה הבאים במגע עם העור והחלב](#).

02-02-05-07	נוהל שימוש וטיפול בחלב אם בבית החולים	עמוד 8 מתוך 12
-------------	---------------------------------------	----------------



9.3. נספח 3: [עקרונות לאחסון חלב.](#)

9.4. נספח 4: [הנחיות לשאיבה, שימוש וטיפול בחלב אם בבית חולים – הנחיות להורים.](#)

9.5. נספח 5: [עדכוני הנוהל.](#)



נספח 1: צוות רב-מקצועי לארגון השימוש הבטוח בחלב אם שאוב

הקמת צוות הכולל את הגורמים הבאים:

1. נאונטולוג;
2. אחות טיפול נמרץ יילוד;
3. דיאטנית;
4. יועצת הנקה;
5. מהנדס תעשייה וניהול/הנדסת אנוש;
6. נציג היחידה למניעת זיהומים;
7. נציג היחידה לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים.

תפקידי הצוות:

1. עידוד זמינות של חלב אם מיטבי ובטוח לשימוש לתינוקות במוסד;
2. ביצוע הדרכות שוטפות לאנשי המקצוע המעורבים בתהליך;
3. הקמת תהליכי בקרה ייעודית על התהליך;
4. ביצוע תצפית על תהליכים בזמנים שונים בכל סביבות העבודה בהן מתקיים התהליך;
5. התכנסות לניתוח הסיכונים בתהליך ע"פ השלבים השונים ומציאת פתרונות למניעת טעויות בזיהוי חלב אם;
6. ביצוע התהליך בהתאם לאמות המידה המקובלות למניעת זיהומים.

דוגמא לבחינת התהליך:

- ההדרכה הניתנת בנוגע לשאיבה, זיהוי החלב, מקומות האחסון, הרשאות לגישה למקררים ולמקפיאים השונים - השאיבה- ערכות שאיבה, סביבה פיסית, היגיינה - גורם מורשה לזיהוי החלב ודרך זיהוי חלב האם - תהליך העברת החלב למקרר והגורמים המעורבים	שאיבה וזיהוי החלב
- ניתוח הסביבה הפיסית של אחסון החלב ושיפור התנאים לשמירתו - הפרדת מיכלי האחסון בקירור/הקפאה - הרשאות להוצאת חלב אם מהמקרר - בחינת תנאי הקירור וההקפאה	אחסון החלב (לפני או אחרי הכנה)
- טיפול בהכנת חלב לכל מטופל בנפרד - ביצוע זיהוי חד חד ערכי של חלב האם - קיום ההוראה הרפואית טרם החלוקה למנות ו/או הוספת התוספים - ביצוע בקרה על התאמה להוראת הרופא	חלוקת החלב למנות/הוספת תוספים שונים
- קביעת תהליך חימום וזיהוי החלב - קביעת הגורם המורשה להכנסת והוצאת החלב מהמחמם - חלוקה החלב לילודים - קביעת הגורם המורשה להאכלה - קביעת תהליך הזיהוי אל מול המטופל	חימום והאכלה

**נספח 2: הטיפול בכלים ובאביזרים לשאיבה הבאים במגע עם העור והחלב**

- א. כלים לאחסון ולשאיבה (על פי דרישות חוזר זה) יהיו עמידים לניקוי ועיקור בטמפרטורות גבוהות.
- ב. יש לפעול לפי הנחיות יצרן המדיח המסוגל להשיג חיטוי ברמה גבוהה לטמפרטורה של 70 מעלות צלזיוס לפחות.
- ג. כאשר המדיח אינו עומד בדרישות אלו, נדרש לבצע עיקור של הצידוד בהתאם להנחיות העיקור המקובלות.
- ד. חשוב להקפיד על תנאים של משך החשיפה לחום טמפרטורה המדיח בהתאם לפירוט שלהלן:
- C70° במשך 100 דקות או
 - C75° במשך 30 דקות או
 - C80° במשך 10 דקות או
 - C90° במשך 1 דקה



נספח 3: עקרונות לאחסון חלב

חלב אם טרי

חום חדר	טמפרטורה	אחסון מומלץ	אחסון מרבי
	22-25 מעלות צלסיוס	4 שעות	6 שעות
מקרר	4 מעלות צלסיוס או פחות	3 ימים	5 ימים
מקפיא א. מקרר עם תא הקפאה נפרד ב. מקפיא נפרד הקפאה עמוקה	18 – מעלות צלסיוס או פחות	עד ל 3 חודשים	12 חודשים

שימוש בחלב אם לאחר הפשרה

חלב אם לתינוק	24 שעות מרגע ההפשרה
חלב אם מבנק חלב אם	24 שעות מרגע ההפשרה

הערות:

- חלב אם ישמר בחלק אחורי של מקרר/מקפיא, מוגן מכניסת אוויר חם בפתיחת הדלת בהעברה בצידנית יוכנס חלב האם הטרי כשהוא מצונן 4 מעלות צלסיוס. ניתן יהיה לשמרו עד 8 שעות עד השימוש.

נספח 5: עדכוני הנוהל

מהדורת הנוהל	תאריך פרסום	עדכוני הנוהל
שנייה	ספטמבר 2024	• עדכון סעיף המבוא
		• עדכון של סעיף השיטה
		• סידור הנוהל לפי הפורמט ההדסאי החדש

היסטורית כתיבה ואישור הנוהל

מהדורה	תאריך פרסום	כותבי ומעדכני הנוהל	אישורי הנוהל
ראשונה	אוקטובר 2020	פרופ' סמדר אבן-טוב פרידמן מנהלת האגף לנאונטולוגיה, רננה שוורץ מתאמת הנקה ה"צ, איילת שמואלי מתאמת הנקה ע"כ, מיכל נאה דיאטנית, מרב יוסף מרכזת תחום נהלים. הנוהל עודכן ע"י: פרופ' סמדר אבן-טוב פרידמן מנהלת האגף לנאונטולוג; טליה לב, מ.מ אחות ראשית פגיה ויועצת הנקה; שחרית הרמן מתאמת הנקה ה"צ, איילת שמואלי מתאמת הנקה ע"כ, מיכל נאה דיאטנית, מרב יוסף מרכזת תחום נהלים.	פרופ' יורם וייס מנהל בית החולים ע"כ, דר' תמר אלרם מנהלת בית החולים ה"צ, דר' רלי אלון סמנכ"לית סיעוד ומקצועות הבריאות, פרופ' סמדר אבן-טוב פרידמן מנהלת האגף לנאונטולוגיה, ד"ר יונתן אוסטר, אילנה גרוס מרכזת תחום מניעת זיהומים, עופר ורדימון מהנדס, רבקה ליכשטנטט ניהול סיכונים